脑卒中患者言语功能康复计划个体化设计与追踪

沈艳红
内蒙古赤峰市元宝山区平庄矿区医疗集团总医院

摘要：目的：探讨脑卒中患者言语功能康复计划个体化设计与追踪。方法：选取本院 2024 年 5 月-2025 年 5 月收治的 40 例存在言语功能障碍的脑卒中患者，采用随机数字表法分为对照组与实验组，各 20 例。对照组患者实施常规言语康复护理，实验组患者实施个体化言语功能康复计划设计与全程追踪干预。对比两组患者干预 3 个月后的言语功能评分、生活质量评分。结果：实验组患者的 WAB 量表中自发言语、听觉理解、复述、命名评分均显著高于对照组，P＜0.05。实验组患者的 SS-QOL 量表中生理功能、心理状态、社会参与、自我照顾、生活满意度评分均显著高于对照组，P＜0.05。结论：对脑卒中言语功能障碍患者实施个体化康复计划设计与追踪干预，能有效改善患者的言语功能，提高其生活质量，值得在临床推广应用。

关键词：脑卒中；言语功能障碍；个体化康复计划；康复追踪

据世界卫生组织统计，全球每年新发脑卒中患者超 1500 万，其中约 20%-40%的患者会出现不同程度的言语功能障碍，主要表现为失语症、构音障碍等[1]。言语功能障碍不仅影响患者的日常沟通，还会导致其心理压力增加、社会参与度降低，甚至引发焦虑、抑郁等负面情绪，严重降低患者的生活质量与康复信心[2]。目前，临床针对脑卒中言语功能障碍的康复干预多以“统一模式”为主，缺乏对患者个体差异的考量，导致康复效果参差不齐。个体化康复计划强调“以患者为中心”，通过全面评估患者的具体情况，制定针对性的康复目标与方案，并结合全程追踪调整干预策略，确保康复措施的连贯性与有效性[3]。基于此，本文通过对比常规康复护理与个体化康复计划设计及追踪干预的效果，旨在明确个体化方案对脑卒中患者言语功能恢复的促进作用，为临床康复护理提供新的思路与实践参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院 2024 年 5 月-2025 年 5 月收治的 40 例脑卒中后言语功能障碍患者作为研究对象，采用随机数字表法将患者分为对照组与实验组，各 20 例。对照组：男 12 例，女 8 例；年龄 52-78 岁，平均（65.3±5.2）岁；脑卒中类型：缺血性脑卒中 14 例，出血性脑卒中 6 例；失语类型：运动性失语 8 例，感觉性失语 5 例，混合性失语 4 例，构音障碍 3 例。发病至干预时间（1.8±0.5）个月。实验组：男 11 例，女 9 例；年龄 50-79 岁，平均（64.8±5.5）岁；脑卒中类型：缺血性脑卒中 13 例，出血性脑卒中 7 例；失语类型：运动性失语 7 例，感觉性失语 6 例，混合性失语 3 例，构音障碍 4 例。发病至干预时间（1.7±0.6）个月。两组患者的一般资料比较，P＞0.05。

1.2 纳排标准

纳入标准：①符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南（2024 年版）》[4]中脑卒中的诊断标准；②存在明确的言语功能障碍；③意识清晰，能配合完成康复训练与评估；④患者及家属知情同意并签署知情同意书。

排除标准：①合并严重认知障碍、精神疾病或沟通障碍；②存在严重心、肝、肾等重要脏器功能衰竭；③存在口腔、咽喉部器质性病变影响言语功能；④中途退出研究或失访者。

1.3 方法

对照组患者应用常规言语康复护理，采用临床通用的言语康复训练方法，指导患者进行元音、辅音的发音练习，每日 1 次，每次 30 分钟；通过卡片、图片等工具，引导患者识别并复述常用词汇及短句，每日 1 次，每次 30 分钟；告知家属与患者沟通时需放慢语速、使用简单语言，避免打断患者表达，每日沟通指导 15 分钟；向患者及家属讲解脑卒中言语功能障碍的康复原理、训练注意事项，每周 1 次，每次 20 分钟。

实验组患者应用个体化言语功能康复计划设计与追踪，成立个体化康复干预小组，成员包括康复医师、言语治疗师、责任护士、家属。详细内容如下：

（1）全面评估：使用 WAB 量表评估患者的自发言语、听觉理解、复述、命名能力，确定失语类型与严重程度；采用 MMSE 量表评估患者的记忆力、注意力、定向力，判断认知水平对言语康复的影响；记录患者的血压、血糖控制情况，是否合并肢体活动障碍、吞咽困难等并发症；通过访谈法了解患者的心理状态、康复期望、家属支持情况。

（2）个体化康复计划设计：根据评估结果，为患者制定“阶梯式”康复目标与个性化方案；①轻度失语/构音障碍患者：结合患者兴趣进行节奏性发音练习，如跟着音乐哼唱简单旋律并清晰发音；模拟日常场景，引导患者主动表达需求，每次 40 分钟，每日 1 次；选择患者熟悉的短文，指导其阅读并书写简单句子，每次 20 分钟，每日 1 次。②中度失语患者：通过“指令执行”（如拿起杯子、指向窗户）、“图片匹配”（如将杯子图片与喝水场景匹配）提升理解能力，每次 30 分钟，每日 1 次；采用“词语联想”（如由医生联想到医院）、“实物命名”（如识别身边的手机、钥匙并命名），每次 30 分钟，每日 1 次；每周 2 次，每次 20 分钟，通过倾听患者诉求、分享康复成功案例，缓解焦虑情绪。③重度失语患者：指导患者使用手势、表情、图片卡片进行沟通，每次 30 分钟，每日 1 次；通过听觉刺激、口腔肌肉运动训练，促进发音器官功能恢复，每次 20 分钟，每日 2 次；家属协同训练：教会家属协助患者进行口腔运动按摩，每日 2 次，每次 10 分钟。

中国知网 https://www.cnki.net

表1　言语功能评分对比（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	例数	自发言语	听觉理解	复述	命名	总分
实验组	20	22.3±3.1	23.5±2.8	15.2±2.5	14.8±2.3	75.8±8.2
对照组	20	16.5±3.5	17.2±3.2	10.1±2.7	9.5±2.6	53.3±9.1
t 值	-	5.547	6.626	6.198	6.828	8.214
P 值	-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

表2　两组患者生活质量评分对比（$\bar{x}\pm s$，分）

组别	例数	生理功能	心理状态	社会参与	自我照顾	生活满意度	总分
实验组	20	15.2±2.1	14.8±2.3	15.5±2.0	14.9±2.2	15.1±2.4	75.5±8.5
对照组	20	10.3±2.5	9.6±2.5	9.8±2.3	10.1±2.4	9.7±2.6	49.5±9.2
t 值	-	6.711	6.845	8.363	6.593	6.825	9.283
P 值	-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

（3）康复计划实施：言语治疗师在康复室进行一对一训练，每次40-60分钟，每日1次；根据患者情况，制定“家庭训练任务清单”，家属记录训练完成情况，每周反馈给干预小组；若患者合并吞咽困难，同步进行吞咽功能训练，避免因吞咽问题影响言语训练；若患者血压、血糖波动，及时与医生沟通调整用药，确保康复训练安全。

（4）全程追踪与方案调整：言语治疗师每周使用简化版WAB量表评估患者康复进展，记录训练过程中的问题；医护人员通过面对面访谈或电话随访，了解患者家庭训练依从性、家属支持情况，收集患者与家属的反馈意见；根据追踪结果及时优化计划，可增加“电话沟通训练”；中度患者若复述能力提升缓慢，可调整为“短句分解复述”（如将我今天去公园散步分解为我去公园、我散步）；重度患者若非语言沟通熟练，可尝试简单发音组合训练（如ba-ba、ma-ma）。

1.4 观察指标

（1）言语功能评分：干预3个月后，采用WAB量表评估两组患者的言语功能，该量表包括自发言语、听觉理解、复述、命名，总分100分，分数越高表示言语功能越好[5]。

（2）生活质量评分：干预3个月后，采用SS-QOL量表评估两组患者的生活质量，该量表包括生理功能、心理状态、社会参与、自我照顾、生活满意度，总分100分，分数越高表示生活质量越好[6]。

1.5 统计学方法

采用SPSS 26.0软件，计量、计数资料分别以（$\bar{x}\pm s$）、%表示，行t、x^2检验。P＜0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 言语功能评分对比

实验组患者的WAB量表中自发言语、听觉理解、复述、命名评分均显著高于对照组，P＜0.05。见表1。

2.2 生活质量评分对比

实验组患者的SS-QOL量表中生理功能、心理状态、社会参与、自我照顾、生活满意度评分均显著高于对照组，P＜0.05。见表2。

3 讨论

脑卒中后言语功能障碍的康复是一个复杂且长期的过程，其核心在于“精准匹配患者需求”——不同失语类型、严重程度及个体背景的患者，对康复训练的内容、强度、方式需求存在显著差异[7]。常规言语康复护理采用“一刀切”的模式，忽略患者的个体差异，导致部分患者因训练难度不匹配、内容缺乏兴趣而降低依从性，最终影响康复效果[8]。

本文中，实验组采用的“个体化康复计划设计与追踪”模式，通过多维度评估、阶梯式目标设定、动态追踪调整，有效解决常规护理的局限性。从结果来看，实验组患者的WAB各项评分显著高于对照组，说明个体化方案能精准针对患者的言语功能短板制定训练内容——如对重度失语患者优先进行非语言沟通与口腔运动训练，为后续发音恢复奠定基础；对轻度失语患者通过情景对话模拟日常场景，快速提升沟通实用性，这种“对症训练”显著提升言语功能恢复效率[9]。

在生活质量方面，实验组的SS-QOL各维度评分均优于对照组，这一结果与言语功能改善直接相关：言语功能的恢复使患者能够表达需求、参与家庭交流，减少因沟通障碍导致的孤独感与无助感，进而改善心理状态与社会参与度。同时，个体化方案中对并发症的同步管理，也减轻患者的身体不适，间接提升生活质量[10]。

综上所述，对脑卒中言语功能障碍患者实施个体化康复计划设计与追踪干预，能有效改善患者的言语功能，提高其生活质量，值得在临床推广应用。

参考文献：

[1]王哲,万勤,黄昭鸣,等.成年卒中后非流畅性失语症患者言语韵律功能特征[J].中国康复理论与实践,2024,30(8):979-992.

[2]闫华.不同靶点重复经颅磁刺激对脑卒中后失语症患者语言康复的对比研究[D].中国人民解放军空军军医大学,2025,7(4):32-33.

[3]刘耀华,李俊,闫静.基于证据总结的目标康复训练对老年缺血性脑卒中后言语障碍患者功能恢复的影响[J].老年医学与保健,2024,30(2):348-352.

[4]孟倩,王利勇,段亚男.基于眼动追踪技术的认知康复训练对老年脑卒中患者注意力功能恢复的影响[J].老年医学与保健,2025,31(1):93-97.

[5]林冰冰,倪静蕾,熊啸,等.基于功能性近红外光谱技术探讨头皮针联合言语康复训练对脑卒中后失语症患者的影响[J].康复学报,2024,34(6):590-596.

中国知网　https://www.cnki.net

[6]高海晓,张朝辉,杜以君,等."醒脑开窍"针刺法联合言语康复训练改善中风后运动性失语言语功能及生存质量的临床疗效观察[J].现代中医药,2025,27(4):59-60.

[7]李雪青,邓娟娟,熊丽,等.开玄醒神针法联合Schuell刺激法治疗缺血性脑卒中后运动性失语症的临床观察[J].广州中医药大学学报,2023,14(8):38-39.

[8]张阳,陈立君,靳宝莲,等. 吞咽言语诊疗仪在脑卒中患者吞咽功能障碍中的效果及对营养状态的影响研究[J]. 中华保健医学杂志,2023,25(5):515-518.

[9]曹迎,金霞,汪吴臻.计算机辅助执行功能训练联合言语训练对脑卒中后构音障碍患者的康复效果[J].中国听力语言康复科学杂志,2025,23(1):79-82.

[10]倪静蕾,柴林松,王梦雪,等.脑卒中后失语症中医证素分布与语言功能及日常生活能力的相关性研究[J].广州中医药大学学报,2025,9(6):20-21.

中国知网 https://www.cnki.net